ONEMA-POP-049 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-049 — Suspeita de Oclusão de Cateter Venoso

Central — PICC/Hickman

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Suspeita de Oclusão de Cateter Venoso Central — PICC/Hickman. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Suspeita de oclusão de PICC/Hickman: dificuldade de infusão ou aspiração; não confundir com clampeamento ou dobra externa. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro habilitado: EPI, luvas, material de inspeção e conectores compatíveis; paciente: identificação do dispositivo, prescrição e insumos pactuados. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Tipo do cateter, última utilização, sintomas de trombose/infecção, resistência, clamp, curvatura externa e integridade. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Confirmar dispositivo, indicação e prescrição vigente; higienizar mãos e adotar técnica asséptica.

2. Suspender imediatamente infusão diante de resistência, dor ou edema.

3. Inspecionar externamente clamps, dobras, conexões e posição visível sem tracionar o cateter.

4. Avaliar dor, edema do membro/pescoço, febre, calafrios, rubor e alteração do comprimento externo.

5. Não forçar flush, não usar seringa pequena para vencer resistência e não tentar desobstrução química sem

protocolo especializado.

6. Se suspeita de trombose, extravasamento, ruptura ou infecção, manter dispositivo sem uso e encaminhar.

7. Comunicar equipe responsável pelo acesso para avaliação da permeabilidade e eventual intervenção

autorizada.

8. Registrar achados, volume não administrado, integridade e conduta de encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dor torácica, dispneia, edema agudo, febre com instabilidade ou ruptura: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar não manipular conexões e não utilizar cateter até liberação formal.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 CDC — Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections (review 2024) — https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infection/

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.